Mongo, Guéra

Ici, la chaleur tue surtout des enfants déjà malades. La mesure la plus efficace contre la chaleur consiste donc à maintenir la prise en charge de la malnutrition, et à mettre l'eau à portée de main avant mars.

PROVINCE	DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA PRINCIPAL
Guéra (échelle provinciale)	980 prévus, dont 330 en octobre et 210 en mars ; 350 déjà survenus (juin–septembre)	Prévision sur 6 mois, octobre 2026 – mars 2027	Chaleur pour les enfants malades et malnutris ; pénurie d'eau ; méningite de janvier à mai ; la soudure 2027

15 recommandations vérifiées sur 15. 9 corrigées, 0 non vérifiée, 6 contre-indiquées (les six fiches « À ne pas faire » ; l'une d'elles, sur l'ancienne vaccination contre la méningite, est issue de la vérification). Les 8 étapes de la rubrique « Pour vous » ont aussi été vérifiées, et 4 ont été corrigées. Donnée d'exposition : données du El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs, méthodologie à paraître. Elles sont publiées pour la province du Guéra, et non pour Mongo, et ne comptent que la chaleur. La part de Mongo n'a pas été calculée, faute de pouvoir confirmer la population actuelle de la ville. Le Guéra ne figure dans aucun des circuits de financement préétablis examinés : le cadre d'action anticipatoire de l'ONU contre la sécheresse, le projet de filets sociaux de la Banque mondiale, le protocole d'action précoce de la Croix-Rouge et les zones prioritaires du plan de réponse humanitaire

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



12,18° N 18,68° E, Tchad · Natural Earth

- **Le risque.** Au Guéra, 13,3 % des jeunes enfants souffraient de malnutrition aiguë en 2024, et les ménages paient déjà 1 000 à 1 250 FCFA par jour pour l'eau.
- **Pour vous.** Ce mois-ci, faites mesurer le périmètre brachial (bracelet MUAC) de chaque enfant de moins de cinq ans au centre de santé ; la prise en charge est en principe gratuite.
- **L'argent.** 176 à 549 millions de FCFA (300 000 à 936 000 USD) ; c'est le traitement de la malnutrition jusqu'au dernier kilomètre qui sauve le plus de vies.
- **À ne pas faire.** Ne comptez pas sur l'ancienne vaccination contre la méningite : elle ne protège pas contre la souche de sérogroupe C qui circule aujourd'hui dans l'est du Tchad.

Pour vous, habitants	8 étapes	p. 2
Que faire	**9** actions	p. 5
Qui fait quoi	matrice RACI	p. 14
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 14
À ne pas faire	**6** points	p. 16
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 19
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 21
Références	sources	p. 23

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

2026. Après vérification, l'objectif de financement est passé de 249 millions de FCFA (424 000 USD), montant proposé par le panel, à 238 millions de FCFA (405 800 USD) (−4 %). Deux de ses lignes sont désormais des réserves, débloquées uniquement sur déclencheur.

POUR VOUS, HABITANTS

8 ÉTAPES

Pour une famille de Mongo, la chaleur d'El Niño est surtout dangereuse pour un enfant déjà maigre ou fiévreux, et elle survient quand l'eau est rare et chère. La saison de la méningite va de janvier à mai, et la prochaine soudure commence en juin. Les actions classées plus bas s'adressent à la province et à ses partenaires. Voici celles que vous pouvez mener vous-même.

Faites mesurer dès maintenant le périmètre brachial (bracelet MUAC) de chaque enfant de moins de cinq ans au centre de santé, puis chaque mois jusqu'en mai *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 1

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
novembre 2026, puis chaque mois	gratuit en principe ; renseignez-vous à l'unité nutritionnelle	les jeunes enfants

Un enfant atteint de malnutrition aiguë sévère risque plusieurs fois plus qu'un enfant bien nourri de mourir d'une fièvre, d'une diarrhée ou d'une journée de forte chaleur. L'unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) de l'Hôpital provincial de Mongo prend en charge la malnutrition aiguë sévère (MAS) avec l'appui de l'UNICEF et de l'Union européenne. Selon son propre personnel, les cas doublent entre avril et octobre. La gratuité de la prise en charge est la règle en principe, mais elle n'a pas pu être confirmée dans un texte officiel. *

À partir de janvier, emmenez le jour même à l'hôpital toute personne qui a une forte fièvre et la nuque raide *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 3

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
janvier–mai 2027	le transport ; le traitement est gratuit en période d'épidémie	les enfants et les jeunes adultes

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À Adré, dans l'est du Tchad, les cas de méningite sont passés de 18 en janvier à 109 en mars 2026, et environ un enfant hospitalisé sur huit est décédé. Une seule dose du bon antibiotique, donnée tôt, sauve la plupart d'entre eux. L'injection de MenAfriVac que beaucoup ont reçue il y a des années ne protège que contre le sérogroupe A. Elle ne protège pas contre la méningite à sérogroupe C qui circule aujourd'hui.*

Avant mars, gardez à la maison deux à trois jours d'eau dans des récipients couverts

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 4

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
28 février 2027	environ 2 000 FCFA (3,40 USD) par bidon de 20 litres (prix relevé au Cameroun), plus 2 000 à 3 750 FCFA (3,40 à 6,40 USD) d'eau	l'eau de boisson pendant les semaines les plus chaudes

En mars 2026, les ménages des secteurs 1, 2 et 3 payaient 1 000 à 1 250 FCFA par jour aux vendeurs d'eau ambulants (pousse-pousse), parce que trop peu de forages fonctionnaient, et la demande augmente avec la chaleur. Une réserve achetée avant la saison chaude protège la famille des jours où les prix sont les plus élevés.

Gardez tous les récipients d'eau couverts, et frottez-les avant de les remplir à nouveau*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 4

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
dès maintenant, et pendant toute la saison sèche	un couvercle	la famille contre le choléra et la diarrhée

Le choléra a atteint Bitkine, au Guéra, en 2025 : 220 cas et 7 décès à la fin septembre. L'eau achetée au pousse-pousse et conservée à découvert est le moyen le plus facile pour la maladie de passer d'une maison à l'autre.*

Gardez à la maison dix sachets de sels de réhydratation orale pour un enfant qui a la diarrhée*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 2

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ÉCHÉANCE
30 novembre 2026

COÛT POUR VOUS
prix au Tchad non trouvé

PROTÈGE
les jeunes enfants

Les sels de réhydratation orale (SRO) maintiennent en vie un enfant qui a la diarrhée jusqu'à l'arrivée des secours : selon des études groupées, ils réduisent d'environ 69 % les décès d'enfants dus à la diarrhée. Le centre de santé en dispose ; demandez aussi le traitement au zinc.*

Aux heures les plus chaudes, de mars à mai, reposez-vous à l'ombre et mouillez-vous la peau ; un ventilateur n'aide qu'en dessous d'environ 38 °C*

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE
mars–mai 2027

COÛT POUR VOUS
aucun

PROTÈGE
les personnes âgées, les travailleurs et toute personne malade

Les mois les plus chauds à Mongo vont de mars à mai, avec environ 39 °C en moyenne à la mi-journée, et le service météorologique a prévu 45 °C en mai 2024. Par chaleur très sèche, un ventilateur qui souffle sur une peau sèche peut réchauffer encore le corps. Au-dessus d'environ 38 °C, mouillez d'abord la peau, puis laissez l'air en mouvement la rafraîchir.*

Pendant les vagues de chaleur, passez chaque jour voir un voisin âgé ou malade, et signalez à votre chef de quartier les personnes qui vivent seules

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 6

ÉCHÉANCE
à partir de novembre

COÛT POUR VOUS
aucun

PROTÈGE
les personnes que personne d'autre ne vient voir

Ceux qui meurent par forte chaleur sont ceux que personne ne voit. Le chef de quartier a déjà un délégué à la mairie ; un nom qui lui est transmis peut donc parvenir à ceux qui organisent les visites.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Achetez le mil ou le sorgho pour la soudure une fois la nouvelle récolte arrivée sur le marché, pas avant, et conservez-le dans des sacs hermétiques

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 8

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
fin novembre 2026 – janvier 2027	les prix varient ; un sac de 50 kg en vente à prix subventionné coûtait 7 500 FCFA (12,80 USD) dans le Mandoul en 2026	l'alimentation de juin à septembre 2027

Fin août, après une mauvaise saison des pluies, le prix du sac de berbéré a triplé en une semaine à Mongo, et la récolte de cette année est en retard, jusqu'en novembre. Les prix sont actuellement à leur plus haut saisonnier. Achetez une fois le nouveau grain arrivé sur le marché, et conservez-le dans des sacs hermétiques à triple couche si la délégation de l'agriculture peut en fournir.

Ce qu'il faut demander aux responsables

- Demander à la Délégation provinciale de la santé publique du Guéra si les enfants du Guéra reçoivent bien les 14 sachets d'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE) par semaine (action 1).*
- Demander au gouverneur du Guéra et à la mairie de Mongo quand le château d'eau de 500 m³ sera mis en service, et quels forages seront réparés avant mars (action 4).
- Demander à la mairie comment les ménages de Mongo peuvent être inscrits au Registre social unifié (RSU), afin que des transferts monétaires puissent leur parvenir en cas de crise (action 5).
- Demander à la Délégation du commerce si l'ONASA organisera des ventes à prix subventionnés au Guéra en 2027 (action 8).

CE QUE CETTE LOCALITÉ DEVRAIT FAIRE — PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic. Les éclairages experts qui soutiennent chaque action

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs éclairages sont parvenus indépendamment est le pari le plus sûr.

1. Maintenir le dépistage et le traitement de la malnutrition jusqu'en mai : financer l'acheminement jusqu'au dernier kilomètre et la supervision, et s'assurer que les enfants du Guéra reçoivent la dose complète

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE · GESTIONNAIRE D'URGENCE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Délégation provinciale de la santé publique du Guéra, avec l'UNICEF et l'UNT de Mongo	dès maintenant et jusqu'en mai 2027	176 millions de FCFA (300 000 USD)	les décès d'enfants émaciés dus à la chaleur, à la fièvre et à la diarrhée

L'enquête SMART 2024 a relevé au Guéra 13,3 % de malnutrition aiguë, dont 1,8 % de malnutrition aiguë sévère. Les enfants atteints d'émaciation sévère ont une mortalité environ 11,6 fois supérieure à celle des enfants bien nourris (Olofin et al. 2013). La plupart des décès liés à la chaleur que le modèle compte ici seront ceux de ces enfants, morts du paludisme ou de déshydratation par une journée chaude. Selon l'UNICEF, l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE) du Tchad est financé jusqu'en mai 2027 ; le manque se situe donc dans l'acheminement de l'entrepôt aux centres de santé du Guéra. Le coût suppose 3 000 enfants à environ 100 USD chacun pour l'acheminement et les soins.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : le nombre de 3 000 cas et le coût unitaire de 100 USD sont des hypothèses de planification, sans source. Les chiffres coût-efficacité publiés (42 USD par DALY au Malawi, 53 USD en Zambie) comparent un programme complet à l'absence de programme ; ils surestiment donc la valeur d'un appui au dernier kilomètre ajouté à un programme déjà en place. Le rapport de MSF sur des rations réduites à 10 sachets par semaine concerne l'est du Tchad, et non le Guéra.

2. Aménager d'ici le 15 février un espace ombragé de rafraîchissement et de réhydratation à l'Hôpital provincial de Mongo, et approvisionner les centres de santé en SRO et en zinc

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTIONNAIRE D'URGENCE · SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Délégation provinciale de la santé publique du Guéra, avec l'Hôpital provincial	**15 février 2027, avant la chaleur de mars à mai**	**environ 3 millions de FCFA (5 100 USD), estimation**	**les décès dus à la chaleur chez les nourrissons et les personnes âgées, enregistrés comme « fièvre »**

Les mois les plus chauds à Mongo atteignent en moyenne environ 39 °C à la mi-journée (mars 39,0 °C, avril 38,7 °C, mai 38,6 °C, normales 1961–1990), et l'Agence nationale de la météorologie (ANAM) a prévu 45 °C pour le 3 mai 2024. Le Tchad n'a pas de système officiel d'alerte chaleur-santé ; l'hôpital doit donc se préparer sans en disposer. En septembre 2025, le ministre a constaté que l'hôpital manquait de personnel et de kits de césarienne.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Transférabilité : les données sur les plans chaleur (Ahmedabad, Hess et al. 2018) proviennent d'une ville indienne, et celles sur les SRO portent sur la diarrhée, non sur la chaleur. Corrigé lors de la vérification : octobre a une moyenne de 34 °C ; le chiffre élevé d'octobre dans le tracker reflète donc une chaleur supérieure à la normale de la saison, et non les semaines les plus chaudes.

3. Avant janvier, constituer des stocks de ceftriaxone et de tests rapides dans chaque hôpital de district, suivre la méningite chaque semaine, et tenir prête la demande de vaccins d'urgence

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTIONNAIRE D'URGENCE · SANTÉ PUBLIQUE · HISTORIEN | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Délégation provinciale de la santé publique du Guéra	31 décembre 2026 ; surveillance à partir de la semaine 1 de 2027	29 millions de FCFA (50 000 USD), en réserve	un délai de deux à trois semaines avant la confirmation d'une épidémie et l'arrivée du vaccin

La première épidémie de méningite à sérogroupe C du Tchad a frappé le Ouaddaï en 2025, et le pays a utilisé pour la première fois le nouveau vaccin Men5CV, en riposte, en juillet 2025. Le Groupe international de coordination (ICG) libère des vaccins lorsqu'un district dépasse le seuil épidémique (10 cas suspects pour 100 000 habitants par semaine, pour un district de 30 000 à 100 000 habitants) et en fait la demande dans les sept jours. Aucun cas n'a été signalé au Guéra. Les districts sont Mongo, Bitkine, Melfi et Mangalmé.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : une campagne préventive de Men5CV avant janvier n'a aucune filière d'approvisionnement (aucune campagne préventive de Gavi n'est prévue pour le Tchad) ; la demande en riposte est donc le plan réaliste. La baisse de 94 % de la méningite obtenue au Tchad grâce au MenAfriVac concernait le sérogroupe A.

4. Avant mars, financer les réparations, les pièces détachées et un mécanicien pour les forages existants de Mongo, chlorer les points d'eau, et publier la date de mise en service du château d'eau

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SCEPTIQUE · HISTORIEN · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Gouverneur du Guéra, avec la mairie, la délégation provinciale de l'hydraulique et la STE	**28 février 2027**	**non chiffré ; non financé**	**des ménages privés d'eau par son prix en pleine chaleur ; le choléra**

La ville dépend toujours de l'ancienne installation de 100 m³ de la Société Tchadienne des Eaux (STE). Un château d'eau de 1 000 m³ et 20 km de canalisations avaient été promis en avril 2021 ; en juin 2025, le projet était ramené à 500 m³ et 14 km, pour une livraison en décembre 2025, et rien n'indique qu'il fonctionne. Sur 600 sites ruraux étudiés, la possibilité d'une réparation abordable était le meilleur indicateur du bon fonctionnement d'une pompe, et elle faisait défaut dans 62 % d'entre eux (Whaley 2019). Construire de nouveaux forages n'a de sens qu'avec un budget de réparation associé. Des comités de gestion de l'eau ont été formés à Mongo en avril 2025, mais aucun fonds de réparation n'a été mentionné.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : aucun décompte des forages de Mongo, en état de marche ou en panne, n'a été trouvé, et les données portent sur le milieu rural, non urbain. L'idée de convenir d'un prix plafond avec les vendeurs d'eau ambulants n'a pas été éprouvée ici ; elle est donc gardée comme question, et non comme action.

5. Faire inscrire le Guéra dans les financements qui se déclenchent déjà automatiquement : le cadre sécheresse 2027, le guichet « chocs » des filets sociaux de la Banque mondiale et le registre social

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Ministère de l'Action sociale, avec OCHA Tchad et le gouverneur du Guéra	avant la révision du cadre 2027 (printemps 2027)	administratif ; en cas de déclenchement, environ 8 384 FCFA (14,28 USD) par personne et par mois	des ménages contraints de vendre leur bétail sur un marché en baisse pour survivre

Le cadre d'action anticipatoire du Tchad contre la sécheresse s'est déclenché le 5 mai 2026, sur la base des prévisions saisonnières du CEPMMT (ECMWF). La part du PAM, 4,9 millions USD (1,96 million USD du CERF et 2,94 millions USD de l'Autriche), a atteint 170 472 personnes dans sept provinces, dont le Guéra ne faisait pas partie. Le projet de filets sociaux adaptatifs et productifs de la Banque mondiale (100 millions USD de l'IDA et 20 millions USD d'un fonds fiduciaire) couvre neuf provinces, sans le Guéra. Il comporte un guichet « chocs » pour 40 000 ménages en cas de sécheresse. Le volet de réponse aux chocs du Registre social unifié (RSU) ne couvre que le Kanem et le Barh-el-Gazel.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : l'enveloppe propre du CERF était de 4,4 millions USD, répartie entre la FAO, l'UNICEF et le PAM ; les 4,9 millions USD correspondent à l'activation du PAM, contribution autrichienne comprise, et les deux montants ne doivent pas être additionnés. L'estimation de 10 000 ménages du Guéra à 50 306 FCFA chacun (503 millions de FCFA, 857 000 USD) est notre propre calcul, et non un chiffre de la Banque mondiale.

6. Diffuser l'alerte par la Radio Communautaire de Mongo, les chefs de quartier, les imams et les pasteurs, en arabe tchadien et en langues locales, et demander aux vendeurs d'eau ambulants de signaler les foyers qui cessent d'acheter de l'eau

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | INTERVENANT DE TERRAIN · SCEPTIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Mairie de Mongo, avec les chefs de quartier et les responsables religieux	à partir de novembre 2026	quasi nul	des alertes qui n'atteignent jamais les ménages isolés et pauvres

La Radio Communautaire de Mongo a formé des producteurs en langues locales en janvier 2026. Son club d'auditeurs organise déjà des opérations bénévoles de salubrité. L'arabe tchadien relie les peuples hadjeraï de Mongo, dont les langues comprennent le dangaléat, le kenga et le migaama ; le français n'est utilisé que dans les bureaux. Chaque chef de quartier recense les personnes âgées isolées, les personnes handicapées et les élèves des écoles coraniques pour une visite quotidienne les jours de forte chaleur. Un ménage qui dépense 1 000 FCFA par jour pour l'eau et cesse d'en acheter est en difficulté, et le vendeur d'eau ambulant est le premier à le savoir.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : Radio Sôt-Al-Nadja (98,3 FM), ouverte en août 2026, est une station évangélique ; elle devrait relayer les messages, mais pas les porter en premier dans une ville majoritairement musulmane. La diffusion d'émissions en dangaléat ou en kenga n'a pas été confirmée.

7. Porter les messages d'orientation, les SRO et le dépistage du paludisme dans les campements nomades autour de Mongo, Melfi et Bitkine, en associant volontaires de la Croix-Rouge et agents de santé communautaires

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | GESTIONNAIRE D'URGENCE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Délégation provinciale de la santé publique, avec le comité du Guéra de la Croix-Rouge du Tchad	novembre 2026 – mars 2027	environ 5 millions de FCFA (8 500 USD), estimation ; non financé	des décès dans des campements qui n'atteignent jamais un centre de santé

En octobre 2021, dans des campements nomades près de Melfi, 52 personnes sont tombées malades de ce qui s'est révélé être le paludisme, et 7 ou 8 sont décédées. Elles s'en étaient remises à des guérisseurs itinérants. Le Tchad dispose depuis 2015 d'une politique de prise en charge communautaire du paludisme et de la pneumonie ; le dépistage et le traitement devraient donc être assurés par ses agents de santé communautaires, les volontaires de la Croix-Rouge se chargeant de repérer les malades et de les orienter.

Corrigé lors de la vérification : aucune source n'autorise les volontaires de la Croix-Rouge à dépister ou à traiter. Les bilans plus lourds qui circulaient à l'époque (50 à 91 décès) ont été démentis par le ministère.

8. Demander à l'ONASA d'étendre au Guéra ses ventes à prix subventionnés pour la soudure 2027, et faire publier chaque semaine par la délégation du commerce les prix des céréales à Mongo

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ALIMENTATION · HISTORIEN | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ONASA, avec la Délégation provinciale du commerce	demande d'ici mars 2027 ; ventes avant juin	subvention des ventes non chiffrée	une soudure 2027 abordée aux prix d'août 2026

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Les pires années du Guéra sont survenues une saison après un El Niño, et non pendant : la famine de 1983–1984 a suivi l'épisode de 1982–1983, et le Guéra a figuré parmi les régions les plus touchées en 2010, après une mauvaise récolte en 2009. Les pluies de 2026 ont été tardives et irrégulières (FAO, septembre 2026). L'ONASA a organisé des ventes à prix subventionnés dans le Mandoul à partir du 5 août 2026, à 7 500 FCFA les 50 kg de sorgho ou de maïs, mais aucune vente au Guéra n'a été trouvée. Le délégué du commerce a annoncé des contrôles sur les marchés après la flambée d'août.

Corrigé lors de la vérification : l'ONASA reconstitue ses stocks en partie par des importations, et non par des achats locaux à la récolte ; la proposition « acheter localement à la récolte » a donc été retirée. La publication hebdomadaire des prix n'existe pas encore, et FEWS NET ne suit pas le marché de Mongo.

9. Rédiger pour 2027 un protocole d'action précoce de la Croix-Rouge contre les vagues de chaleur au Guéra, sur le modèle de celui qu'utilise le Burkina Faso à Ouagadougou

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ÉCONOMISTE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTÉ

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Croix-Rouge du Tchad, avec la FICR et l'ANAM	**rédigé avant la saison chaude 2027**	**référence : 219 935 CHF (157 millions de FCFA, 267 000 USD) pour Ouagadougou ; non financé**	**l'arrivée de la prochaine vague de chaleur sans aucun fonds débloqué à l'avance**

Le seul protocole d'action précoce de la Croix-Rouge du Tchad concerne les inondations dans six provinces (192 833 CHF, approuvé en août 2024, non activé en 2025). Le protocole contre les vagues de chaleur du Burkina Faso pour Ouagadougou finance l'alerte précoce, l'eau, les visites aux malades chroniques et des transferts monétaires, sur la base d'une prévision de température du type de celles de l'ANAM. Une version pour le Guéra nécessiterait un seuil fixé à partir de la station de Mongo.

Corrigé lors de la vérification : cette action protège la saison suivante plus que celle-ci. L'assurance souveraine contre la sécheresse de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (African Risk Capacity) a été écartée, faute de pouvoir confirmer l'éligibilité actuelle du Tchad.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

MATRICE RACI

R = Réalise (exécute le travail) · **A** = Approuve (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = Consulté (sollicité avant) · **I** = Informé (tenu au courant après). Établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées. Personne ici n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition.

Action	Délégation de la santé publique	Hôpital provincial et UNT	UNICEF	Gouverneur du Guéra	Mairie de Mongo	Hydraulique et STE	Chefs de quartier et responsables religieux	Croix-Rouge du Tchad	Ministère de l'Action sociale et OCHA	ONASA et délégation du commerce
1. Traitement de la malnutrition, dernier kilomètre	**A**	**R**	**R**	**I**			**C**			
2. Espace de rafraîchissement à l'hôpital, SRO	**A**	**R**	**C**	**I**				**C**		
3. Préparation contre la méningite	**A/R**	**R**	**C**	**I**			**I**	**C**		
4. Réparation des forages, chloration, date du château d'eau	**C**			**A**	**R**	**R**	**C**			
5. Le Guéra dans les financements préétablis			**C**	**R**	**C**				**A/R**	
6. Alertes et visites de quartier	**C**			**I**	**A**		**R**	**R**		
7. Sensibilisation dans les campements nomades	**A**	**C**		**I**			**C**	**R**		
8. Ventes de céréales et prix hebdomadaires				**C**	**I**				**C**	**A/R**
9. Protocole Croix-Rouge contre les vagues de chaleur	**C**			**I**				**A/R**	**C**	

Ce que montre la matrice : la Délégation provinciale de la santé publique approuve quatre des neuf actions et porte l'essentiel de ce qui sauve des vies. Le gouverneur n'approuve que le volet eau, mais il est informé ou réalise le travail sur la plupart des lignes. Les actions 5, 6 et 8 ne coûtent presque rien ; elles demandent des décisions à N'Djamena et à la mairie, pas de l'argent.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

L'éclairage du philanthrope, rapproché des actions classées et vérifié. Les affectations sont classées selon les vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est limitée par ce que la localité peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins. Elle couvre la province du Guéra, l'unité nutritionnelle de Mongo servant de point de référence.

PLANCHER

176 millions de FCFA (300 000 USD)

OBJECTIF

238 millions de FCFA (405 800 USD)

PLAFOND

549 millions de FCFA (935 800 USD)

PRINCIPALE INCERTITUDE

le nombre réel de cas de malnutrition aiguë sévère au Guéra ; aucun chiffre d'admissions n'a été trouvé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Plancher = traitement de la malnutrition jusqu'au dernier kilomètre, 176,1 millions de FCFA. Objectif = plancher + sensibilisation par la Croix-Rouge (14,7 millions de FCFA) + réserve d'ATPE pour la dose complète (18,1 millions de FCFA) + réserve méningite (29,4 millions de FCFA) = 238,3 millions de FCFA. Plafond = objectif + transferts monétaires aux ménages des enfants en traitement (135,0 millions de FCFA) + doublement du nombre de cas (176,1 millions de FCFA) = 549,4 millions de FCFA. Ne pas débloquer les lignes du plafond avant d'avoir en main les données d'admissions de la délégation provinciale et un opérateur de transferts désigné. Les réparations de forages et la sensibilisation dans les campements sont exclues de l'enveloppe, faute de bénéficiaire désigné. L'objectif a baissé de 4 % lors de la vérification.

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
UNICEF Tchad, affecté à la Délégation de la santé publique et à l'UNT de Mongo	Action 1 : transport, supervision, soins hospitaliers pour environ 3 000 enfants	176,1 millions de FCFA (300 000 USD)	subvention directe (affectée)	Traitement communautaire, programme complet : 42 USD par DALY (Malawi, Wilford 2012), 53 USD par DALY (Zambie, Bachmann 2009) ; surestime un complément au dernier kilomètre	Partiellement confirmé
Croix-Rouge du Tchad, par le siège national ou la FICR	Actions 2 et 6 : SRO, zinc, sensibilisation à la chaleur et orientation à Mongo	14,7 millions de FCFA (25 000 USD)	subvention directe	Aucune étude de coût par décès évité ; couverture peu coûteuse. Aucune subvention de ce montant au Guéra n'est répertoriée	Partiellement confirmé
UNICEF Tchad	Action 1 : ATPE pour rétablir 14 sachets par semaine, s'il s'avère que le Guéra est rationné	18,1 millions de FCFA (30 800 USD)	stock prépositionné, débloqué sur déclencheur	84 000 sachets à environ 0,37 USD ; rationnement documenté uniquement dans l'est du Tchad	Non vérifié pour le Guéra
Délégation provinciale de la santé publique du Guéra	Action 3 : ceftriaxone, tests rapides, surveillance	29,4 millions de FCFA (50 000 USD)	stock prépositionné, débloqué au seuil d'alerte	Traitement présomptif de l'OMS ; le vaccin est fourni gratuitement par l'ICG	Partiellement confirmé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
Opérateur de transferts à désigner	Transferts monétaires aux ménages des enfants en traitement (plafond uniquement)	135,0 millions de FCFA (229 900 USD)	transfert monétaire	Grellety et al. 2017 (RDC) : guérison ×1,35, rechute ×0,30 avec 40 USD par mois pendant 6 mois ; ce transfert-ci est plus faible et plus court	Partiellement confirmé
UNICEF Tchad, affecté comme ci-dessus	Action 1 avec un nombre de cas doublé (plafond uniquement)	176,1 millions de FCFA (300 000 USD)	subvention directe (affectée)	Débloqué uniquement si les données d'admissions dépassent 3 000 enfants	Partiellement confirmé

Le point de vue d'un bailleur : ne pas acheter d'aliment thérapeutique. Selon l'UNICEF, l'ATPE du Tchad est financé jusqu'en mai 2027. Ce qui n'est pas payé, c'est son acheminement de l'entrepôt aux centres de santé du Guéra. L'argent le plus rentable ne coûte rien : faire inscrire le Guéra dans le cadre sécheresse et dans le guichet « chocs » des filets sociaux (action 5).

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · DES CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici.

Compter sur une ancienne vaccination par MenAfriVac, ou attendre une campagne préventive, pour se protéger de la méningite cette saison

CONTRE-INDIQUÉ

Relevé lors de la vérification. Le MenAfriVac ne protège que contre le sérogroupe A. Les épidémies de 2025 et 2026 dans l'est du Tchad étaient dues au sérogroupe C, et environ un enfant hospitalisé sur huit est décédé à Adré. Aucune campagne préventive de Men5CV n'est prévue pour le Tchad.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : traiter toute fièvre avec raideur de la nuque comme une urgence, constituer des stocks de ceftriaxone, et envoyer la demande à l'ICG dès qu'un district franchit le seuil (action 3).*

Des centres de rafraîchissement qui dépendent du réseau électrique ou de ventilateurs, ou qui rassemblent du monde de février à mai*

CONTRE-INDIQUÉ

L'électricité de Mongo provient d'une centrale hybride solaire dont la production était qualifiée de « très faible » en juin 2025. Par chaleur très sèche, les ventilateurs sur une peau sèche font monter la température du corps : dans un essai de 2019, ils se sont révélés nocifs à 47 °C et 10 % d'humidité, et des modélisations ultérieures situent le seuil vers 38–39 °C. Rassembler des personnes de février à mai les réunit aussi en pleine saison de la méningite.

À la place : des espaces ombragés et aérés qui ne demandent pas d'électricité, la peau mouillée exposée à l'air en mouvement, et des soins apportés aux personnes à domicile (actions 2 et 6).

Dire aux gens de « boire plus d'eau » là où l'eau s'achète au jour le jour

CONTRE-INDIQUÉ

Les ménages des secteurs 1, 2 et 3 paient déjà 1 000 à 1 250 FCFA par jour aux vendeurs d'eau ambulants, et réduisent leur consommation d'eau et leur hygiène quand elle coûte trop cher. Un conseil qui ignore le prix ne change rien pour les personnes les plus exposées.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : réparer les forages en panne (action 4), et chercher une aide au coût de l'eau pendant les semaines de pic.

Forer de nouveaux forages sans budget de réparation, sans pièces détachées ni mécanicien

CONTRE-INDIQUÉ

Plus d'un quart des pompes manuelles d'Afrique sont en panne à tout moment, et la possibilité d'une réparation abordable est le meilleur indicateur du bon fonctionnement d'une pompe (Whaley 2019). Les habitants demandent de nouveaux forages, et ils en ont besoin, mais un forage sans fonds de réparation deviendra le prochain forage en panne.

À la place : de nouveaux forages uniquement avec un plan de réparation financé, et réparer d'abord ceux qui existent.

Conserver l'eau à découvert *

CONTRE-INDIQUÉ

Le choléra a atteint Bitkine, au Guéra, en 2025 (220 cas, 7 décès à la fin septembre). L'eau achetée au pousse-pousse et conservée à découvert est facilement contaminée.

À la place : des récipients couverts à col étroit, frottés avant chaque remplissage.

Alerter uniquement en français, ou uniquement par SMS

CONTRE-INDIQUÉ

À Mongo, le français est la langue des bureaux. La plupart des habitants parlent l'arabe tchadien et une langue hadjeraï, et le système d'alerte précoce du Tchad compte peu de relais en dehors des villes.

À la place : la radio communautaire, les chefs de quartier, les imams et les pasteurs, en arabe tchadien et en langues locales (action 6).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1983–1984	Famine au Guéra, l'année qui a suivi l'El Niño de 1982–1983, après deux décennies de guerre qui avaient vidé les greniers	Aucun chiffre trouvé pour le Guéra ; la Croix-Rouge a lancé en 1984 un appel pour 140 000 victimes de la sécheresse dans tout le Tchad	Non documenté
2009–2010 (El Niño)	Sécheresse et déficit céréalier national de 34 % ; le Guéra parmi les provinces les plus touchées	Malnutrition aiguë 16,1 %, sévère 4,9 % au Guéra	L'alerte est venue tard, avec trop peu de partenaires pour intervenir
Août 2011	Choléra après de fortes pluies	152 cas à l'hôpital de Mongo en neuf jours (FICR)	Non documenté
2012	Crise alimentaire au Sahel ; nord du Guéra le plus touché ; à Tassino, des femmes ont extrait des grains de termitières	Aucun bilan des décès trouvé pour le Guéra	Aide ralentie par une reconnaissance tardive de la crise
2021–2026	Château d'eau de Mongo : 1 000 m³ promis en avril 2021, ramenés à 500 m³, livraison prévue en décembre 2025	Ménages payant 1 000 à 1 250 FCFA par jour pour l'eau en mars 2026	Pas encore mis en service, selon toutes les sources disponibles
Octobre 2021	Paludisme dans des campements nomades près de Melfi, d'abord signalé comme une maladie inconnue	52 malades, 7 à 8 décès	Le ministre a mis en garde contre les guérisseurs itinérants
2025	Choléra dans le district de Bitkine	220 cas, 7 décès à la fin septembre	Journées de prévention à Mongo
Août 2026 (El Niño)	Pluies tardives et irrégulières ; le prix du berbéré a triplé en une semaine à Mongo	Sans objet	Contrôles sur les marchés annoncés

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

La récurrence que personne n'a relevée : les années les plus meurtrières du Guéra sont survenues la saison qui a suivi un El Niño, et non pendant. La famine de 1983–1984 a suivi l'épisode de 1982–1983, et la malnutrition de 2010 a suivi la récolte de 2009. Cette note traite du premier choc, la chaleur pour les enfants malades, mais le second, la soudure de juin à août 2027, frappera des ménages dont la saison chaude aura épuisé les réserves. Aucun décès dû à la chaleur ni aucune épidémie de méningite n'a jamais été enregistré au Guéra, ce qui traduit l'absence de surveillance, et non l'absence de danger.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT — NON RÉSOLU

- **Le danger se situe en octobre** (le tracker : 330 des 980 décès) ou **le danger se situe de mars à mai** (le Sceptique et les relevés climatiques : les mois les plus chauds à Mongo). Les deux peuvent être vrais. Le tracker compte la chaleur au-dessus de la normale, et l'anomalie d'octobre coïncide avec le pic de malnutrition et de paludisme. Les registres de décès de Mongo permettraient de trancher, mais la ville n'a pas d'enregistrement des décès opérationnel.
- **Mettre en place un programme contre la chaleur** (Gestionnaire d'urgence) ou **la prise en charge de la malnutrition et du paludisme est le programme contre la chaleur** (Santé publique). Le classement suit la Santé publique, avec un espace de rafraîchissement à l'hôpital comme seule mesure propre à la chaleur.
- **Azithromycine deux fois par an pour tous les enfants de moins de cinq ans** (Santé publique : −14 % de mortalité toutes causes au Niger, essai AVENIR, 2024) ou **ne relève pas de la politique nationale, et ne peut être mis en œuvre avant le pic**. Écarté des actions classées ; à soulever auprès du ministère pour 2027.
- **Acheter les céréales localement à la récolte pour stabiliser les prix** (Alimentation) ou **l'ONASA achète des importations pour ne pas créer de pénurie sur place** (vérification). Maintenu comme demande de ventes au Guéra, et non d'achats locaux.

CE QUE PERSONNE N'A TRAITÉ — ANGLE MORT

Aucun éclairage n'a examiné les femmes enceintes et les naissances par forte chaleur, alors que l'hôpital de Mongo manquait de kits de césarienne et de personnel en septembre 2025. Aucun n'a dénombré les personnes déplacées de Mongo ni les éleveurs de passage en saison sèche, et aucun n'a trouvé la phase du Cadre Harmonisé propre au Guéra pour cette saison. L'enquête nutritionnelle la plus récente date de 2024.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le panel a été constitué par l'auteur. Huit éclairages d'experts simulés ont servi à formuler ces recommandations. Lorsqu'ils concordent, il s'agit d'une hypothèse solide, et non d'un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transférabilité à cette localité et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en rendent compte.

Les chiffres de mortalité sont publiés à l'échelle de la province, pour le Guéra. Ce ne sont pas des chiffres propres à Mongo. La projection El Niño ne couvre que *la chaleur* ; la sécheresse, les inondations, les incendies, la fumée et les mauvaises récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici à partir de l'historique plutôt que d'un chiffre publié.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** La localité a été prise telle qu'indiquée : Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, Tchad. Les chiffres de mortalité n'existent qu'à l'échelle provinciale ; les données propres à la ville servent à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, et non au décompte des décès. La population actuelle de la ville n'a pas pu être confirmée ; aucune part de Mongo dans le chiffre provincial n'est donc donnée.
- **Exposition.** Données du El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, fichier `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs) : Guéra (GADM TCD.7_1), 350 décès supplémentaires dus à la chaleur de juin à septembre 2026, 980 prévus d'octobre 2026 à mars 2027 (octobre 330, novembre 230, décembre 70, janvier 68, février 62, mars 210), soit 1 300 au total ; Tchad, 17 000 ; monde, 857 400. Cette mise à jour remplace le rapport de septembre *451,000 at Risk*. Méthode : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 appliquées aux relations température–mortalité par rapport à une référence 1996–2025. Les chiffres ne comptent que la chaleur ; nous l'avons déduit des données, car les pays froids affichent exactement zéro chaque mois d'hiver. Ils ne sont jamais ajoutés aux projections à long terme de l'Impact Map.
- **Panel d'experts.** Huit éclairages d'experts simulés (gestionnaire d'urgence, spécialiste de santé publique, intervenant de terrain, sceptique, économiste, historien, philanthrope et analyste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié cette localité de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne en français et en anglais, selon un cahier des charges fixe.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les éclairages qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée au regard d'un biais commun (les preuves à l'appui d'une action partagée provenaient-elles d'un contexte semblable à celui-ci ?) avant d'être retenue en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non tranchées en écartant l'un des avis. Les actions ont été

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les affectations de financement ont été rapprochées de la liste classée.

- **Vérification.** Six agents vérificateurs ont examiné chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transférabilité (ces preuves proviennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (peut-on la mettre en œuvre ici avant le pic ?). Les actions financières ont en outre été vérifiées quant à leur disponibilité dans cette juridiction, à l'existence d'un payeur désigné et d'un seuil de déclenchement, et à leur éventuelle existence préalable ; les actions alimentaires, quant aux déclencheurs publiés et au calendrier. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant à la réalité des bénéficiaires, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée.
- **Qui fait quoi.** La matrice RACI est établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées, avec une seule partie qui approuve par action. Il s'agit d'une proposition : aucune organisation qui y figure n'a été contactée ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transférabilité et faisabilité sont toutes établies. *Partiellement confirmé* : établi après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rattaché à une source primaire. *Contre-indiqué* : serait nuisible ou gaspillerait la fenêtre d'action ici.
- **Adaptation Inventory.** Non consulté lors de cette analyse. La page de consultation charge ses données dans le navigateur et, lors d'analyses précédentes, son lien « Download Inventory » menait à un formulaire d'inscription. Aucune action ici ne doit être lue comme sans précédent ; aucune n'a été vérifiée.
- **Montants.** Les coûts sont exprimés en francs CFA d'Afrique centrale (FCFA), avec l'équivalent en dollars américains (USD) entre parenthèses, au taux de 587,14 FCFA = 1 USD. Ce taux découle de la parité fixe de 655,957 FCFA = 1 € et du taux de référence de la BCE de 1 € = 1,1172 USD (30 octobre 2026). Les montants publiés en francs suisses (protocoles de la Croix-Rouge) sont repris tels que publiés.
- **Lecteur.** Aucun rôle n'ayant été indiqué, la rubrique « Pour vous » s'adresse à un habitant. Ses étapes sont tirées des actions vérifiées et de ce que le panel a appris sur les ménages d'ici. Toute étape qui ne découle pas d'une action classée a été vérifiée selon les trois mêmes critères. Le reste du rapport s'adresse à la province et à ses partenaires.
- **Langue.** Cette version française accompagne la version anglaise, le français étant la langue de l'administration tchadienne. Une version en arabe standard moderne, l'autre langue officielle du Tchad, a été ajoutée le 31 octobre 2026. La plupart des habitants de Mongo parlent l'arabe tchadien et une langue hadjeraï ; aucune version n'a été produite dans ces langues, et l'action 6 demande plutôt que les messages clés y soient diffusés à la radio. Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Formulations de santé.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (fraîcheur et ventilateurs, médicaments et doses, traitement de l'eau et SRO, signes de danger, réserves d'urgence et moment où demander de l'aide) sont signalés par « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les relaie doit d'abord les confirmer auprès d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier ou d'un agent de santé communautaire. Ce marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.
- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; lorsque les données sont rares, le rapport le signale et donne le chiffre de l'échelon géographique supérieur, avec le calcul. Chaque source est répertoriée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le panel et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains, et personne n'a été interrogé sur place. Il s'agissait de la deuxième note complète d'une même session ; les vérificateurs ont donc été limités à une quinzaine de recherches chacun. Plusieurs sources (le chapitre nutrition du plan de réponse humanitaire 2025, la base de prix du PAM, une page de l'OMS sur la méningite) n'ont pas pu être lues directement. Aucun décompte des forages de Mongo, aucun nombre de cas de malnutrition aiguë sévère au Guéra, aucune phase du Cadre Harmonisé pour le Guéra et aucun prix du chlore ou des SRO au Tchad n'a été trouvé. Le prix du bidon provient du Cameroun. La carte de localisation situe Mongo à l'échelle du pays.

Références · statut après vérification

Climate Impact Lab, données du El Niño Heat Mortality Tracker v261026 (téléchargées le 30 octobre 2026) ; tracker · confirmé

Nutrition et santé : SMART 2024 Tchad ; UNICEF, UNT de Mongo ; UNICEF, financement de l'ATPE, T2 2026 ; MSF, rationnement dans l'est du Tchad ; UNICEF HAC Tchad 2026 ; Bachmann 2009 ; Wilford 2012 ; Grellety 2017 ; Munos 2010 ; Hess 2018 ; essai AVENIR ; visite du ministre à l'hôpital, sept. 2025 · partiellement confirmé

Chaleur et électricité : normales climatiques de Mongo (OMM/DGMN) ; prévision de l'ANAM, mai 2024 ; Morris 2019, ventilateurs ; centrale hybride solaire de Mongo · partiellement confirmé

Méningite et sensibilisation : campagne Men5CV, Abéché 2025 ; MSF, Adré 2026 ; stocks de l'ICG ; effet du MenAfriVac ; seuils de la méningite ; MenAfriCar ; Croix-Rouge Mongo, mai 2026 ; Melfi 2021 ; prise en charge communautaire ; Radio Communautaire de Mongo ; Radio Sôt-Al-Nadja ; chefs de quartier · partiellement confirmé

Eau : eau des vendeurs ambulants, mars 2026 ; première pierre du château d'eau, 2021 ; visite du château d'eau, juin 2025 ; comités de gestion de l'eau ; Whaley 2019 ; OMS AFRO, rapport de situation choléra, sept. 2025 ; choléra 2011 ; prix du bidon (Cameroun) · partiellement confirmé

Financement : PAM, action anticipatoire, Tchad 2026 ; Anticipation Hub ; Banque mondiale, filets sociaux ; volet chocs du registre social ; sEAP inondations, Tchad ; sEAP vagues de chaleur, Burkina Faso ; plan de réponse humanitaire du Tchad 2026 ; taux de référence de la BCE · partiellement confirmé (ARC : non vérifié, écarté)

Alimentation et historique : prix des céréales à Mongo, août 2026 ; FAO SMIAR (GIEWS) Tchad ; FEWS NET Tchad ; FEWS NET El Niño 2026–2027 ; vente

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

de l'ONASA, Mandoul ; reconstitution des stocks de l'ONASA, 2020 ; ASC Leiden, Guéra ; appel de 1984 ; malnutrition au Guéra, 2010 ; alerte FEWS NET, déc. 2009 ; crise de 2012 · partiellement confirmé

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Généré le 30 octobre 2026 pour Mongo, Guéra. El Niño Ready est une initiative bénévole, sans lien avec la Climate Week NYC, The Climate Group ni l'Université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion